

מטופל בהתקף אסתמה

פעל לפי עקרונות פרוטוקול גישה כללית למטופל

- הערך את חומרת ההתקף
- הושב את המטופל (ככל האפשר)
- שקול מתן חמצן
- התקן עירוני תוך-ורידי או תוך-לשדי
- חבר מוניטור למטופל

האם המטופל באי-ספיקה נשימתית?

- תן אדרנלין 1 ב-I.M.
- תן אינהלציה של ונטולין 2 ואירובנט 3
- תן מגנזיום סולפט 4
- תן סולומדרול 5

האם חל שיפור במצב המטופל?

בזמן הפיניו - חוזרות של ונטולין ואירובנט 2 3

- שקול מתן סיוע נשימתי באמצעות CPAP
- שקול מעבר לפרוטוקול ניהול מתקדם של נתיב האוויר

המטופל בהתקף אסתמה קשה?

- שקול מתן אדרנלין 1 ב-S.C.
- תן אינהלציה של ונטולין 2 ואירובנט 3
- תן סולומדרול 5

האם חל שיפור במצב המטופל?

בזמן הפיניו - תן אינהלציות חוזרות של ונטולין ואירובנט 2 3

- שקול מתן מגנזיום סולפט 4

האם המטופל בהתקף קל או בינוני?

- תן אינהלציה של ונטולין 2 ואירובנט 3
- תן סולומדרול 5

האם חל שיפור במצב המטופל?

בזמן הפיניו - תן אינהלציה נוספת של ונטולין 2

- תן סולומדרול ב-I.V. (אם עוד לא ניתן) 5

- המשך ניטור וטיפול בזמן פיניו דחוף לבית החולים הקרוב
- בצע הערכת מדדים חוזרת כל 5-10 דקות
- תן עירוני סליין בקצב 20 ml/min (מנה מקסימלית 500 ml)
- שקול העברת דיווח מקדים לבית החולים

מתן חמצן לצורך שמירה על ערכי סטורציה של המטופל מעל 94%.

1 אדרנלין

- + מתן ב-S.C. - מינון של 0.3 mg מנה חד-פעמית.
- + מתן ב-I.M. - מינון של 0.5 mg מנה חד-פעמית.
- + יש לנקוט משנה זהירות במטופלים מעל גיל 40 או במטופלים עם היסטוריה של IHD.

2 ונטולין

- + מינון בהתקף אסתמה קל או בינוני - 2.5 mg באינהלציה.
- + מינון בהתקף אסתמה קשה - 5 mg באינהלציה.
- + עד 3 מנות בהפרש של 20 דקות ביניהן, אם יש צורך.
- + אם יש קושי ניכר בהנשמה לאחר אינטובציה - אפשר להזליף ונטולין 5 mg (מהול ב-5 ml סליין) לתוך הטובוס.

3 אירובנט

- + מינון בהתקף אסתמה קל או בינוני - 0.5 mg באינהלציה, מנה חד-פעמית.
- + מינון בהתקף אסתמה קשה - 0.5 mg באינהלציה. עד 3 מנות (בשילוב עם ונטולין).

4 מגנזיום סולפט

- + מינון של 2 gr מנה חד-פעמית.
- + צורת מתן - למהול ב-100 ml תמיסת סליין ולהזליף בתוך 10 דקות.
- + אין לתת מגנזיום סולפט למטופלים שלחץ הדם הסיסטולי שלהם נמוך מ-90 mmHg.

5 סולומדרול

- + מינון של 125 mg.
- + מנה חד-פעמית.

תוכן עניינים > כללי : פרק 3

הערכת חומרת המחלה

אפשר להעריך את חומרת המחלה של המטופל לפי סממנים אלה –
מה תדירות ההתקפים; האם המטופל נזקק לטיפול תרופתי קבוע (לרבות "תלות" בסטרואידים); האם
היו אשפוזים או ביקורים במלר"ד בשנה האחרונה; האם המטופל נזקק להנשמה בעבר.

הערכת חומרת ההתקף

+ התקף קל או בינוני –

תשאול – קוצר נשימה המופיע בזמן מאמץ/פעילות, ללא קוצר נשימה במנוחה.
בדיקה גופנית – קצב הנשימה נמוך מ־30 בדקה, אין שימוש בשרירי עזר, אין רטרקציות בין
צלעיות, הסטורציה מעל 92% באוויר חדר, בהאזנה אקספיריום מאורך עם צפצופים אינספירטורים
ואקספירטורים, המטופל משלים משפטים ללא בעיות.

+ התקף קשה –

תשאול – קוצר נשימה המופיע גם במנוחה.
בדיקה גופנית – קצב הנשימה גבוה מ־30 בדקה, יש שימוש בשרירי עזר, יש רטרקציות בין צלעיות,
הסטורציה מתחת 92% באוויר חדר, הדופק מעל 125 בדקה, בהאזנה אקספיריום מאורך עם
צפצופים אינספירטורים ואקספירטורים, המטופל מתקשה להשלים משפטים.

+ אי־ספיקה נשימתית או מאיימת –

תשאול "סביבתי" – התדרדרות במצב המטופל במהלך השעות/היממה האחרונות/ה.
בדיקה גופנית – המטופל בהכרה מעורפלת/אגיטטיבי, נראה תשוש, מאמץ נשימתי "דל" (מעיד על
התעייפות שרירי הנשימה), הסטורציה מתחת 90% באוויר חדר ואינה משתפרת (או משתפרת
קלות בלבד) עם חמצן, בהאזנה "חזה שקט" (לא ניתן כמעט לשמוע כניסה ויציאה של אוויר).

גורמי סיכון העלולים להעיד על צורך בהנשמה

- + המטופל נזקק בעבר להנשמה או לאשפוז ביחידה לטיפול נמרץ.
- + בשנה האחרונה המטופל אושפז מעל פעמיים בגין אסתמה.
- + בשנה האחרונה המטופל ביקר מעל 3 פעמים במלר"ד בגין אסתמה.
- + המטופל משתמש ביותר מ־2 מכלי ונטולין בחודש.